BONUS 3

Predlošci za prezentaciju slučaja na viziti

Struktura prezentacije od 60 i 120 sekundi, 8 predložaka prema vrsti slučaja, gotove rečenice koje će Vam koristiti na viziti i 6 primjera prezentacija od početka do kraja.

Sadržaj

Kako koristiti ove predloške

Poglavlje 1 · Prezentacija od 60 sekundi

Poglavlje 2 · Prezentacija od 120 sekundi

Poglavlje 3 · 8 predložaka prema vrsti slučaja

Poglavlje 4 · Rečenice koje pomažu na viziti

Poglavlje 5 · 6 primjera prezentacija

Poglavlje 6 · Završna provjera prije prezentacije

Sljedeći korak

NA POČETKU

Kako koristiti ove predloške

Dobra prezentacija slučaja izgovoreni je oblik dobrog opisa: isti redoslijed, ista jasnoća.

> *Na viziti Vam najčešće ne smeta nedostatak znanja, nego gubitak redoslijeda. Predložak čuva redoslijed umjesto Vas; Vi se usredotočite na nalaz.*

Prezentacija je ista kao redoslijed koji koristite pri pisanju opisa **metode u 4 koraka** isti je:

KORAK	EKVIVALENT U PREZENTACIJI
1 · PRIPREMITE	Bolesnik (dob, spol), kliničko pitanje, pretraga i protokol, tehnička adekvatnost.
2 · PREGLEDAJTE	Rečenica «Sustavno sam procijenio»; ukratko navedite koje ste regije pogledali.
3 · OPIŠITE	Glavni nalaz: ispravan pojam, lokalizacija, veličina, rub; usporedba s prethodnom pretragom. Zatim pridruženi nalazi.
4 · SAŽMITE	Zaključak u jednoj rečenici, diferencijalna dijagnoza, preporuka; kome je i kada prijavljen hitni nalaz.

Tri zlatna pravila

1. **Zaključak ne ostavljajte za kraj.** Čak i u prezentaciji od 60 sekundi u prvoj rečenici navedite kliničko pitanje, a u posljednjoj jasan zaključak.
2. **Govorite dok pokazujete sliku.** Dok opisujete nalaz, držite taj presjek otvoren na zaslonu i pokažite ga.
3. **Ne izmišljajte ono što ne znate.** Reći «U to nisam siguran, želio bih to procijeniti zajedno sa svojim mentorom» znak je profesionalnosti.

Praksa

Svaki predložak najprije tri puta isprobajte naglas, mjereći vrijeme. U Radnu bilježnicu upišite svoje vrijeme; cilj je prezentaciju od 60 sekundi završiti za manje od 60 sekundi.

POGLAVLJE 1

Prezentacija od 60 sekundi

Primopredaja dežurstva, vizita u hodniku, kad Vam kažu «ukratko».

TRAJANJE	ŠTO REĆI
0–10 s · Identifikacija i pitanje	«[Dob]-godišnjem/-godišnjoj [bolesniku/bolesnici] zbog [tegobe/kliničkog pitanja] učinjen je [pretraga].»
10–15 s · Tehnika	«Pretraga je dijagnostičke kvalitete.» ili «Procjena je ograničena zbog [ograničenja].»
15–40 s · Glavni nalaz	«U [lokalizaciji] prikazuje se [nalaz] [veličine], [ruba], [denziteta/signala/ehogenosti]. U odnosu na prethodnu pretragu [promjena].»
40–50 s · Pridruženi nalazi	«Pridruženi [nalaz] postoji / ne postoji. [Važan negativan nalaz] nije prikazan.»
50–60 s · Zaključak	«Zaključno, odgovara [dijagnozi]; u diferencijalnoj dijagnozi [1–2 dijagnoze]. [Preporuka]. [Prijavljeno kliničkom timu].»

Tajna kratkoće

U 60 sekundi navedite samo jedan glavni nalaz i najviše dva važna negativna nalaza. Ostalo razradite ako dođe pitanje.

POGLAVLJE 2

Prezentacija od 120 sekundi

Jutarnja vizita, sastanak o slučajevima, trenutak kad Vam mentor kaže «ispričajte od početka».

TRAJANJE	ŠTO REĆI
0–15 s · Identifikacija i klinika	Dob, spol, tegoba i njezino trajanje, relevantna anamneza, kliničko pitanje.
15–25 s · Pretraga i tehnika	Modalitet, kontrast i faza (ili sekvencije), tehnička adekvatnost, postojanje prethodnih pretraga.
25–35 s · Pregled	«Sustavno sam procijenio [regije].»
35–75 s · Glavni nalaz	Potpun opis ispravnim pojmom: lokalizacija, veličina (u dvije ili tri ravnine), rub, unutarnja struktura, imbibicija kontrastom; usporedba.
75–90 s · Pridruženi i negativni nalazi	Komplikacije, pridruženi nalazi, važni negativni nalazi vezani uz kliničko pitanje.
90–110 s · Zaključak i diferencijalna dijagnoza	Zaključak u jednoj rečenici; zašto u diferencijalnoj dijagnozi prvo mislite na to.
110–120 s · Preporuka i komunikacija	Preporuka dodatne pretrage ili praćenja; ako je nalaz hitan, kome je i kada prijavljen.

Česta pogreška

U prezentaciji od 120 sekundi najviše se vremena gubi na rečenici o pregledu. Ne nabrajajte normalne organe jedan po jedan: dovoljno je reći «Ostali parenhimni organi su uredni»; važne negativne nalaze povezane s kliničkim pitanjem ipak navedite zasebno.

POGLAVLJE 3

8 predložaka prema vrsti slučaja

Popunite praznine, ne mijenjajte redoslijed.

PREDLOŽAK 1

Hitni nalaz (poput krvarenja, pneumotoraksa, slobodnog zraka)

1. «Počinjem hitnim nalazom: [nalaz].»
2. Bolesnik, kliničko pitanje, pretraga.
3. Lokalizacija, veličina i učinak nalaza (poput učinka mase, pomaka, kolapsa).
4. Komplikacije i pridruženi nalazi.
5. «U [vrijeme] obaviješten je [klinički tim/liječnik].»

PREDLOŽAK 2

Normalna pretraga

1. Bolesnik, kliničko pitanje, pretraga i tehnička adekvatnost.
2. «Sustavnom procjenom nisam našao patološki nalaz.»
3. Važni negativni nalazi vezani uz kliničko pitanje (npr. «krvarenje, učinak mase i prijelom nisu prikazani»).
4. Ako pretraga ima ograničenja, navedite ih (npr. rana ishemija možda neće biti vidljiva na CT-u bez kontrasta).
5. Po potrebi preporuka.

PREDLOŽAK 3

Tvorba / lezija

1. Bolesnik, kliničko pitanje, pretraga i kontrastne faze.
2. Lokalizacija, veličina, rub, unutarnja struktura i ponašanje lezije nakon kontrasta.
3. Odnos s okolnim strukturama, znakovi invazije.
4. Limfni čvorovi i udaljeni nalazi.
5. Diferencijalna dijagnoza (počevši od najvjerojatnije) i preporuka dodatne pretrage.

PREDLOŽAK 4

Infekcija / upala

1. Bolesnik, klinika (vrućica, bol, laboratorijski nalazi ako postoje), pretraga.
2. Glavni upalni nalaz: lokalizacija, proširenost.
3. Komplikacija: apsces, perforacija, opstrukcija, širenje.
4. Diferencijalna dijagnoza.
5. Preporuka (postoji li kolekcija pogodna za drenažu, je li potrebno praćenje).

PREDLOŽAK 5

Trauma

1. Bolesnik, mehanizam ozljede, pretraga.
2. Najteža ozljeda prva (nalaz opasan po život).
3. Ostale ozljede, sustavnim redoslijedom (od glave prema dolje ili organ po organ).
4. Važni negativni nalazi (npr. «aktivna ekstravazacija kontrasta nije prikazana»).
5. Prijava i preporuka.

PREDLOŽAK 6

Kontrolna pretraga (usporedna)

1. Bolesnik, poznata dijagnoza, datum i modalitet prethodne pretrage.
2. Današnja veličina poznate lezije i promjena u odnosu na prethodnu (izmjereno istom metodom).
3. Postoji li novonastali nalaz.
4. Ukupna procjena: regresija, stabilno, progresija.
5. Preporuka.

PREDLOŽAK 7

Kontrola cijevi / katetera / uređaja

1. Bolesnik, pretraga, kontrolirani uređaj(i).
2. Gdje je vrh svakog uređaja; je li u očekivanom položaju.
3. Komplikacija povezana s uređajem (pneumotoraks, malpozicija, savijanje).
4. Promjena u odnosu na prethodnu snimku.
5. Prijava ako položaj nije odgovarajući.

PREDLOŽAK 8

Slučajni nalaz

1. Prvo kliničko pitanje i odgovor na njega.
2. «Usto je slučajno prikazan [nalaz].»
3. Opis nalaza.
4. Preporuka prema kliničkom značaju i pristupu praćenju koji koristi Vaš odjel.
5. Je li postojao na prethodnim pretragama.

POGLAVLJE 4

Rečenice koje pomažu na viziti

Prava rečenica nosi pravu razinu sigurnosti.

SITUACIJA	REČENICA KOJU MOŽETE UPOTRIJEBITI
Uvod	«[Dob]-godišnjem/-godišnjoj [bolesniku/bolesnici]; zbog [kliničkog pitanja] učinjen je [pretraga].»
Tehničko ograničenje	«Procjena [regije] ograničena je zbog artefakata pomicanja.»
Usporedba	«U usporedbi s [pretragom] od [datum] [nalaz] se po [veličini/izgledu] [povećao/smanjio/nije promijenio].»
Nema prethodne pretrage	«Prethodna pretraga za usporedbu nije dostupna.»
Visoka sigurnost	«... odgovara.»
Srednja sigurnost	«... govori u prilog; u diferencijalnoj dijagnozi može se razmotriti ....»
Niska sigurnost	«... ne može se isključiti.»
Važan negativni nalaz	«S obzirom na kliničko pitanje ... nije prikazano.»
Preporuka	«S obzirom na ... može se preporučiti procjena [pretragom].»
Prijava	«Nalaz je u [vrijeme] priopćen [nadležnom liječniku].»
Pitanje na koje ne znate odgovor	«U to nisam siguran; pročitat ću i javiti Vam se na sutrašnjoj viziti.»
Ako Vaš mentor misli drugačije	«Zbog ... mislio sam na ...; želio bih čuti kako Vi procjenjujete nalaz ....»
Kad ponestaje vremena	«Ukratko: odgovara ..., prijavljeno .... Želite li da pokažem pojedinosti?»
Završetak	«Zaključno ...; moja preporuka je ....»

Izrazi koje treba izbjegavati

- «Čini mi se da nešto ima» — navedite nalaz i njegovu lokalizaciju.
- «Izgleda normalno» — ili je normalno, ili navedite ograničenje.
- «Blago», «izraženo» (bez mjere) — navedite mjeru.
- «Tumor» (kad nema tkivne dijagnoze) — recite «tvorba» ili «tvorbena lezija».
- Na MR-u «denzitet», na UZV-u «opacitet» — koristite pojam koji pripada modalitetu.

POGLAVLJE 5

6 primjera prezentacija

Svi su slučajevi izmišljeni; pripremljeni su samo kako bi prikazali strukturu prezentacije.

PRIMJER 1 · 60 SEKUNDI · PREDLOŽAK 1

CT mozga nakon traume

«Počinjem hitnim nalazom: **akutnom subduralnom hematomu**.

Sedamdesetdvogodišnjem bolesniku nakon pada kod kuće učinjen je CT mozga bez kontrasta zbog poremećaja svijesti. Pretraga je dijagnostičke kvalitete.

Uzduž lijeve frontoparijetalne konveksnosti, paralelno s unutarnjom pločom lubanje, prikazuje se hiperdenzna ekstraaksijalna kolekcija oblika polumjeseca. Prisutna je kompresija lijevog lateralnog ventrikula i pomak središnje linije udesno.

U koštanom prozoru nisam našao prijelom. Pridruženo parenhimsko krvarenje nije prikazano.

Zaključno, odgovara akutnom subduralnom hematomu s učinkom mase. Nalaz je u 03.10 priopćen liječniku hitnog prijama.»

PRIMJER 2 · 60 SEKUNDI · PREDLOŽAK 7

RTG prsnog koša u intenzivnoj njezi

«Šezdesetpetogodišnjoj bolesnici nakon intubacije učinjena je AP snimka prsnog koša uz krevet radi kontrole tubusa. Prisutna je blaga rotacija, dostatna za procjenu.

Vrh endotrahealnog tubusa neposredno je iznad razine karine; distalnije od položaja koji naš odjel očekuje. Vrh desnog jugularnog središnjeg venskog katetera u razini je gornje šuplje vene. Nazogastrična sonda seže ispod ošita.

Pneumotoraks nije prikazan. U odnosu na prethodnu snimku nema nove konsolidacije.

Zaključno, endotrahealni tubus je distalno smješten; preporučuje se procjena njegova povlačenja. Prijavljeno liječniku intenzivne njege.»

PRIMJER 3 · 120 SEKUNDI · PREDLOŽAK 4

Bol u desnom donjem kvadrantu, CT abdomena

«Dvadesetosmogodišnji bolesnik javio se zbog boli u desnom donjem kvadrantu i vrućice koje traju dva dana; kliničko pitanje je akutni apendicitis. Učinjen je CT abdomena i zdjelice s kontrastom u portalnoj venskoj fazi; prethodne pretrage nema. Pretraga je dijagnostičke kvalitete.

Abdomen sam sustavno procijenio: slobodni zrak, parenhimni organi, crijeva, krvne žile i zdjelica.

Promjer apendiksa je povećan, stijenka zadebljana i imbibira se kontrastom. U lumenu je hiperdenzno žarište koje odgovara apendikolitu. U periapendikularnom masnom tkivu vidi se zamućenje i mala količina slobodne tekućine.

Nisam našao kolekciju koja odgovara apscesu ni slobodni zrak. Stijenka terminalnog ileuma i cekuma je uredna. Desni bubreg i tijek uretera su uredni, kamenac nije prikazan.

Zaključno **nekompliciranom akutnom apendicitisu** odgovara. U diferencijalnoj dijagnozi mogu se razmotriti divertikulitis cekuma i terminalni ileitis, ali nalaz je usmjeren na apendiks.

Nalaz je priopćen specijalizantu opće kirurgije.»

PRIMJER 4 · 120 SEKUNDI · PREDLOŽAK 3

Plućna tvorba na CT-u prsnog koša

«Šezdesetosmogodišnji bolesnik s dugogodišnjim pušenjem i kašljem koji traje tri mjeseca; zbog zasjenjenja na RTG-u prsnog koša učinjen je CT prsnog koša s kontrastom. Za usporedbu postoji samo RTG prsnog koša od prije mjesec dana.

Napravio sam sustavnu procjenu u plućnom i medijastinalnom prozoru.

U gornjem režnju desnog plućnog krila prikazuje se solidna tvorba nepravilnih i spikuliranih kontura, s heterogenom imbibicijom kontrastom. Tvorba odgovara zasjenjenju na snimci. Postoji sumnja na širenje do pleure; invazija stijenke prsnog koša nije izražena.

U desnoj hilarnoj i donjoj paratrahealnoj regiji prisutni su povećani limfni čvorovi. U lijevom plućnom krilu nisam našao čvor. Nadbubrežne žlijezde i jetra obuhvaćeni presjekom su uredni; u kostima nisu prikazane litičke lezije.

Zaključno **govori u prilog primarnom malignomu pluća** tvorba i hilarno-medijastinalna limfadenopatija. Za tkivnu dijagnozu i određivanje stadija preporučuje se daljnja obrada.

Opis bih želio konačno dovršiti zajedno sa svojim mentorom.»

PRIMJER 5 · 60 SEKUNDI · PREDLOŽAK 2

Glavobolja, normalan CT mozga

«Četrdesetogodišnjoj bolesnici zbog glavobolje koja traje tjedan dana učinjen je CT mozga bez kontrasta. Pretraga je dijagnostičke kvalitete.

Sustavnom procjenom nisam našao patološki nalaz.

Krvarenje, učinak mase ni pomak središnje linije nisu prikazani. Ventrikuli i cisterne su uredni. Diferencijacija sive i bijele tvari je očuvana. U koštanom prozoru nema patologije; sinusi su prozračni.

Znamo da je CT bez kontrasta ograničen u prikazu nekih patologija; ako kliničko pitanje i dalje postoji, dodatna pretraga može se razmotriti zajedno s kliničkim timom.»

PRIMJER 6 · 120 SEKUNDI · PREDLOŽAK 6

Praćenje lezije jetre

«Pedesetpetogodišnja bolesnica operirana zbog malignoma debelog crijeva; radi praćenja poznate solitarne lezije jetre učinjen je CT abdomena s kontrastom u portalnoj venskoj fazi. Usporedio sam ga s CT-om od prije šest mjeseci. Pretraga je dijagnostičke kvalitete.

Abdomen sam sustavno procijenio.

Poznata hipodenzna lezija u desnom režnju jetre, izmjerena istom metodom i na istom presjeku kao na prethodnoj pretrazi, smanjila se. Rubovi i unutarnja struktura lezije nisu se bitno promijenili.

U jetri nisam našao novu leziju. Nalaz koji odgovara limfadenopatiji, ascitesu i peritonealnim implantatima nije prikazan. U području anastomoze nema izražene patologije. U plućnim bazama obuhvaćenima presjekom nisu prikazani čvorovi.

Zaključno, kod poznate lezije jetre **smanjenje veličine**; nema nove lezije. U usporedbi s prethodnom pretragom može se procijeniti kao odgovor na liječenje.

Interval praćenja može se odrediti prema planu kliničkog tima.»

POGLAVLJE 6

Završna provjera prije prezentacije

Prije vizite odvojite 2 minute.

Prije svake prezentacije

- [ ] Dob, spol i kliničko pitanje bolesnika mogu reći u jednoj rečenici.
- [ ] Moja bilješka o pretrazi, kontrastnoj fazi ili sekvencijama i tehničkoj adekvatnosti je spremna.
- [ ] Otvorio sam prethodnu pretragu i usporedio (ili zabilježio da je nema).
- [ ] Presjek koji prikazuje glavni nalaz spreman je na zaslonu.
- [ ] Za glavni nalaz koristim ispravan pojam (denzitet / signal / ehogenost).
- [ ] Imam barem dva važna negativna nalaza vezana uz kliničko pitanje.
- [ ] Moj zaključak u jednoj rečenici i diferencijalna dijagnoza su spremni.
- [ ] Ako postoji hitni nalaz, znam kome je i kada prijavljen.
- [ ] Prezentaciju sam jednom u sebi uvježbao, mjereći vrijeme.

Zlatno pravilo

Jedino što će Vašem mentoru ostati u pamćenju s vizite jest Vaša posljednja rečenica. Zaključak napišite unaprijed i izgovorite ga od riječi do riječi.

U edukativne svrhe. Ovaj materijal ne zamjenjuje specijalizaciju, nadzor mentora, kliničku prosudbu ni nalaz specijalista.

Sljedeći korak

Sada odaberite jedan slučaj iz 100 praktičnih slučajeva i uz odgovarajući predložak od 1 do 8 održite prezentaciju od 60 sekundi, mjereći vrijeme.

Za pripremu pitanja koja Vas mogu dočekati na prezentaciji **300 pitanja za vizitu i usmeni ispit**prijeđite na.